EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 84870
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-05-20 11:18:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	:SILVIA ELENA MU►OZ RAMIREZ			**RUN**	:6.122.996-5
F.Nac	:13-09-1941	**Edad**	:82 AÑOS, 8 MESES	**Género**	:Femenino
Dirección	:LOS AROMOS			**Comuna**	:SAN NICOLAS
Previsión	:FONASA B	**Teléfono**	:977454192		
Fecha Ingreso	:2024-05-18	**Fecha Egreso**	:2024-05-20 11:18:00	**Causal**	:MEDICA
Condición	:VIVO	**Destino**	:HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) ITU en tratamiento
2) IC
3) EPOC
4) ERC etapa IV
5) LES

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos derivda por medico particular por urocultivo positivo para peudomonas.
Tiene sintomatiologia muy vaga de sensacion de pesadez , dificultad para iniciar el chorro micional , pero no tiene sindrome miccional agudo.
No tiene dolor lumbar tipico , no tiene fiebre ni presneta compromiso del estado general.
Crea 2.7 / PCR 6.1 / Na 138 / K 5.5 / CL 101
GB 9500 / PL 61.000 / HB 13
Orina bacterias abundantes / Nitritos + / Leucocitos 11-25 sin placas de pus
Se decide ingreso para terapia ATB ajustada acorde a Fx renal

Paciente HDN estable, afebril, sin dolor,
Ex de lab 20/05 -> albumina 3,6, crea 2,6; PCR 29,1; BUN 61; uremia 131; Na/K/Cl 142/5/107; Gb 8,2; Hb/Hcto 11.6/34.6; plaq 52000 (prev 61000), segment 82% VHS 18;
Ex fisico -> Vigil; CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Abdomen BDI; RHA (+), sin megalias, sin signos de irritacion peritoneal
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflcito
3) INfeccioso: con aprametros inflamatorios a la baja, se planteara HODOm para culmino de terapia ATB, se solicitaran examenes de control dentro de 72 hrs

INDICACIONES AL ALTA

1. Regimen Hiposodico
2. Reposo Relativo
3. Meropenem 500mg ev cada 12 horas por 3 dias
4. Atorvastatina 10mg vo al dia por 3 dias
5. Paracetamol 500mg vo cada 12 horas. por 3 dias
6. Furosemida 40mg al dia vo por 3 dias
7. Alopurinol 100 al dia vo por 3 dias
8. Prednisona 10mg al dia por 3 dias
9. Ipratropio 2 puff c6hrs por AC
10. Salmeterol 2 puff cada 12 horas. por AC
11. Loratadina 10 mg al dia VO por 3 dias
12. Hidroxicloroquina un comp al dia VO
13. -Calcio 1 al dia VO
14. -Cotrimoxazol forte 1 al dia LMV
15. Examenes de control dentro de 72 hrs

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO